INTRODUCCIÓN

En la Medicina Moderna, la enfermera tiene necesidad de especializarse si desea alcanzar los altos niveles de calidad y eficiencia que de ella necesitan los hospitales de especialidades.

La enfermera quirúrgica adquiere jerarquía especial si se considera la gran cantidad de conocimientos, la perfección de destrezas y la madurez de criterio que son necesarios para ser una buena instrumentista.

Es por ello que presentamos el siguiente manual de las TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN OFTALMOLOGÍA mas comunes, con el fin de ampliar y actualizar los conocimientos a todo el personal que labore en las Unidades Quirúrgicas esperando sea de gran interés.

JUSTIFICACIÓN

El presente manual está enfocado a los procedimientos quirúrgicos mas comunes en el área oftalmología, y tiene como finalidad ampliar y actualizar los conocimientos al personal de enfermería; y al mismo tiempo sirva como guía o consulta dentro de la unidad.

OBJETIVO GENERAL

Que el personal de enfermería de la unidad quirúrgica, conozca en base a la patología del paciente, su manejo adecuado el peri-operatorio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Proporcionar al personal de enfermería, conocimientos en base a patologías mas frecuentes de la especialidad en cirugía oftálmica.

2.- Llevar a cabo un adecuado manejo del paciente quirúrgico durante el peri-operatorio.

3.- Dar a conocer las actividades especificas tanto de la enfermería quirúrgica como de la enfermera, circulante para brindar una atención de calidad al paciente durante su e estancia en quirófano.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL OJO

El ojo es el órgano receptor de la visión y contiene más de la mitad de los receptores del cuerpo humano y por si fuera poco, una gran parte de la corteza cerebral se dedica al procesamiento de la información visual.

Las estructuras externas del ojo incluyen:

1) Órbita ósea.
2) Músculos oculares.
3) Párpados.
4) Conjuntiva.
5) Aparato lagrimal.

Órbita ósea:

La órbita ósea proporciona alojamiento para el globo ocular. Se ubica en la parte anterior del cráneo, dentro del hueso frontal. El tejido adiposo que tapiza la cavidad orbitaria, proporciona una superficie acolchada para el globo ocular. Aunque la mayor parte de la órbita se compone de un tejido óseo delgado, su borde es de mayor espesor, dándole una mayor protección.

Músculos oculares:

Los seis músculos extraoculares, que mueven el globo ocular,reciben inervación de los pares craneales III, IV ó VI. Dichos músculos son los rectos superior, inferior, externo e interno del ojo, y oblicuos superior e inferior oculares. En general, sus unidades motoras son pequeñas. Algunas moto neuronas inervan sólo dos o tres fibras musculares (una cantidad mucho menor que en ninguna otra parte, excepto la laringe) lo cual se hace posible los movimientos rápidos, uniformes y precisos de los ojos. Los músculos extraoculares mueven el globo en varias direcciones (lateral, medial, superior e inferior). Por ejemplo para mirar hacia el lado derecho es necesario contraer en forma conjunta los músculos rectos externo derecho e interno izquierdo del ojo, así como la relajación simultánea del recto interno derecho y externo izquierdo del ojo. Los músculos oblicuos preservan la estabilidad rotacional del globo ocular. Los movimientos del ojo se coordinan y sincronizan en los circuitos del tallo encefálico y el cerebelo.

Párpados:

Se da este nombre a los pliegues cutáneos superior e inferior que cubren a los ojos durante el sueño, los protegen contra la luz excesiva y los cuerpos extraños, y distribuyen secreciones lubricantes sobre los globos oculares. El párpado superior, de mayor movilidad que el inferior, comprende en su porción superior el músculo elevador del párpado superior. El espacio entre los pliegues superior e inferior, en medio del cual queda expuesto el globo ocular, es la hendidura palpebral. Sus ángulos se llaman canto externo, más angosto y cercano al temporal, y canto interno, más ancho y próximo a los huesos nasales. En el canto interno, hay una pequeña eminencia rojiza, la carúncula lagrimal, que contiene glándulas sebáceas y sudoríparas. El material blancuzco que a veces se acumula en este canto proviene de estas glándulas.

De la parte superficial a la profunda, cada párpado consiste en epidermis, dermis, tejido subcutáneo, fibras del músculo orbicular de los párpados, placa tarsal, glándulas tarsales y conjuntivas. La placa tarsal es un pliegue grueso de tejido conectivo que les confiere forma y sostén a los párpados. Cada placa comprende una fila de glándulas sebáceas modificadas y alargadas, conocidas como glándulas tarsales (de Meibomio), las cuales secretan un líquido el cual impide que los párpados se adhieran uno al otro. La infección de estas glándulas hace que se forme un tumor o quiste palpebral, llamado chalazión.

Conjuntiva:

La conjuntiva es una capa fina de mucosa protectora compuesta de epitelio cilíndrico estratificado con numerosas células caliciformes, que se halla sostenida por el tejido conectivo areolar. La conjuntiva palpebral reviste la cara interna de los párpados, mientras que la conjuntiva bulbar va de los párpados a la superficie anterior del globo ocular, en plano lateral a la córnea. La dilatación y congestión de vasos sanguíneos de la conjuntiva bulbar por irritación o infección locales ocasionan el enrojecimiento ocular.

Aparato lagrimal:

El aparato lagrimal, integrado por un grupo de estructuras, produce y drena las lágrimas. Las glándulas lagrimales, cada una del tamaño y forma aproximados de una almendra, secretan un líquido acuoso (que sale a través de seis a doce conductos lagrimales) el cual es vertido en la superficie conjuntival del párpado superior. Desde allí, las lágrimas fluyen en sentido medial sobre la cara anterior del globo ocular y entran por dos pequeños orificios, los puntos lagrimales; luego, pasan a dos conductos, los canales lagrimales, que desaguan en el saco lagrimal, y de éste pasan al conducto lacrimonasal, que drena las lágrimas en las fosas nasales, justo debajo del cornete nasal inferior.

Las lágrimas son una solución acuosa que contiene sales, algo de moco y lisozima, una enzima protectora que destruye las bacterias. Además protegen, limpian, lubrican y humectan el globo ocular. Después de secretadas, las lágrimas fluyen en sentido medial sobre la superficie del globo ocular, gracias al parpadeo. Cada glándula produce diariamente casi un mL de esta solución.

ESTRUCTURAS INTERNAS DEL OJO:

1) Capas del globo ocular.
2) Cámaras del ojo.
3) Cristalino.

CAPAS DEL GLOBO OCULAR:

El globo ocular contiene varias capas protectoras externas:

a) esclerótica.
b) Córnea.
c) Cuerpo ciliar.
d) Coroides.
e) Iris.

La esclerótica:

Está constituida por un grueso tejido fibroso y blanco que rodea aproximadamente tres cuartas partes del globo ocular. Conforma la capa externa que da sostén al globo ocular, formando una capa continua con la córnea que cubre la porción anterior del ojo.

La córnea:

Está constituida por una membrana delgada y transparente que cubre la parte anterior del globo ocular. Esta capa no contiene vasos sanguíneos y se encarga de refractar los rayos de luz a medida que éstos penetran en el interior del ojo.

La coroides:

Está situada inmediatamente por debajo de la esclerótica y es un tejido ricamente vascularizado y cargado de pigmentos oscuros. La principal función de la coroides es la de evitar que la luz se refleje en el interior del ojo.

El cuerpo ciliar:

Es una extensión de la coroides. Está formado por un tejido muscular al cual se unen los ligamentos suspensorios. Los ligamentos mantienen al cristalino en su lugar. Además los procesos ciliares que son pliegues de tejido unidos a la cara interna de la porción anterior del cuerpo ciliar, dan lugar a la formación del humor acuoso. Este es un líquido que llena las cámaras anterior y posterior del ojo.

El Iris:

Es la parte coloreada del ojo y se compone principalmente de tejido muscular. El iris tiene forma circular, pudiéndose abrir o cerrar para permitir la entrada de luz en el interior del ojo.

La pupila:

Se encuentra ubicada en el centro del iris y puede dilatarse o contraerse de acuerdo a la acción del iris,

La retina:

Constituye la capa mas interna del ojo. Esta es la denominada capa fotorreceptora del ojo. Descansa sobre el interior de la cara posterior del globo ocular. La luz se refleja sobre la retina, pasando a través de la porción anterior del ojo, para luego transmitirse como impulsos nerviosos dando así lugar al sentido de la visión.

El ojo contiene varias cámaras ocupadas por líquidos nutritivos. El iris separa dos cámaras ubicadas por delante del cristalino. La cámara anterior se encuentra ubicada directamente por delante del iris, mientras que la cámara posterior se ubica directamente por detrás de este último. Ambas cámaras están ocupadas por humor acuoso el cual es secretado por los procesos ciliares. Debido a que este líquido se produce de forma ininterrumpida, debe contar con una vía de salida desde el interior del globo ocular. La vía de salida constituye el conducto de Schlemm. Éste conducto se ubica por dentro de la esclerótica y deriva el líquido hacia el interior del sistema venoso.

Humor vítrio:

Es una sustancia de consistencia gelatinosa que ocupa la cavidad posterior del ojo, ubicada directamente por detrás del cristalino. Ésta sustancia es de vital importancia para mantener la forma del globo ocular.

Cristalino.

El cristalino está ubicado directamente por detrás del iris y está formado por una estructura biconvexa clara rodeada por una cápsula transparente, se mantiene en posición por medio de los ligamentos suspensorios que se encuentran unidos a la cápsula. Esta zona de suspensión es el punto en el cual se unen el cuerpo ciliar de la coroides. Los ligamentos suspensorios modifican la forma del cristalino y hacen que los rayos de luz que transcurren a través de él proyecten una imagen nítida sobre la retina.

QUERATOPLASTIA PENETRANTE

Objetivo:

Que el tejido corneal sea aceptado al máximo por el receptor

Concepto:

La queratoplastia penetrante, también denominada trasplante de cornea, es una cirugía donde el tejido corneal anormal del receptor es sustituido por tejido corneal sano del donante.

Posición:

Decúbito dorsal.

Anestesia:

General.

Instrumental:

Blefarostato.
Juego (set) de anillos de flieringa.
Porta agujas fino.
Tijeras cornéales derecha e izquierda.
Pinzas 0.12 (2).
Tijeras vannas.
Juego (set) de trépanos 7, 7.5, 8 y 8.5 mm.
Pinzas de Jaffe para hilos.
Tijeras de Stevens rectas.
Recipiente de cristal.

Suturas:

Nylon 10/0.
Seda 9/0.

Material de consumo:

Jeringa num. 10.
Jeringa de 10 ml.
Jeringa de insulina.
Aguja 20 y 22.
Gasa 10 x 10.
Healón.
Solución salina balanceada
Micropore.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
QUERATOPLASTÍA PENETRANTE

Previo lavado mecánico quirúrgico de manos secado de las mismas, procedo a vestirme con bata estéril y calzarme guantes con técnica cerrada. Visto mesa riñón y de mayo, acomodo instrumental por tiempos quirúrgicos. Visto al personal medico y se da por iniciado el acto quirúrgico.

La instrumentista proporciona pinza 0.12 y el trépano del número indicado, el cirujano prepara el tejido donante adaptándolo a la medida exacta necesaria para el ojo receptor la enfermera proporciona visco elástico , el recipiente de cristal y guarda el injerto hasta que el cirujano este listo para su implante.

Una vez extraído el injerto, con el lado endotelial hacia arriba, aplica encima visco elástico y lo tapa con un recipiente.

La enfermera proporciona blefarostato para que el cirujano efectué abertura palpebral , la instrumentista proporciona anillo de flieringa en porta agujas castro viejo, con seda 610 el cirujano realiza fijación ocular, posteriormente, la enfermera proporciona trepano de troutman, se efectúa trepanación corneal superficial de diámetro 7.5 a 8.5 mm. Del receptor la instrumentista proporciona tijeras cornéales derecha e izquierda y guarda el tejido trepanado en calidad de muestra, el cirujano lleva acabo Iridectomía periférica, la instrumentista proporciona tijeras, vannas injerto donante y pinzas 0.12 el cirujano coloca el injerto donante, la instrumentista proporciona seda 9/0 en porta agujas, pinza 0.12 de tijeras desfeums recta y el cirujano efectúa fijación provisional con 8 puntos separados suturan injerto en forma continua con nylon 20/0 en porta agujas fino, pinzas 0.12, pinzas Jaffe para hilos, tijeras Stevens recta, retoma la cámara anterior, la enfermera proporciona solución salina balanceada para irrigación oftálmica en jeringa de 3cc. Con cánula #27 y aire con jeringa de 3cc, con cánula No.- 27 se proporciona oclusor de gasa para parche ocular.

CORRECCIÓN DE ESTRABISMO

Objetivo:

La corrección de los músculos mejora la estética y la visión.

Concepto:

La cirugía de músculos se efectúa con el propósito de corregir el alineamiento incorrecto de los ojos. Existen varias técnicas para el tratamiento del estrabismo, que se agrupan entres grandes grupos: 1.- Cirugía de músculos horizontales. 2.- Cirugía de músculos verticales, y 3.- Cirugía de músculos oblicuos. En la recección del músculo recto externo se extirpa una porción del músculo, y el extremo seccionado se vuelve a insertar al punto original de inserción. En la retroinseción del músculo recto interno el músculo se secciona en el sitio de inserción, y luego se sutura en un punto mas posterior.

Posición:

Decúbito dorsal.

Tipo de anestesia:

Local

Instrumental:

Equipo de estrabismo.
Equipo básico de oftalmología.
Cable de electro cauterio y cuchillo cabeza de bronce .
Equipo de asepsia.

Ropa:

Bulto de ropa A y B.

Material de consumo:

Hoja de bisturí num. 15
Gasa 10 x 10.
Jeringas desechables de 5 cm.
Agujas desechables 20 y 25.
Hisopos.

Sutura:

Vicryl 6/0-1
Vicryl 7/0-1

Indicaciones:

Endotropía no acomodativa.
Parálisis del tercero, cuarto y sexto pares craneales.
Hiperfusión del oblicuo inferior derecho o inferior izquierdo.
Hiperfusión de oblicuo superiores.

Contraindicaciones:

Mal estado general del paciente.
Conjuntivitis.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
(CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE ESTRABISMO)

Se recibe paciente en sala de quirófano por el equipo quirúrgico, se coloca al paciente en mesa quirúrgica en posición de cubito dorsal, se inicia anestesia local.

Previo lavado mecánico y quirúrgico de manos y secado de las mismas, procedo a vestirme con bata estéril y calzarme con guantes con técnica cerrada, visto mesa riñón y de mayo, visto el cirujano y ayudante, lavo instrumental con solución salina, lo seco y acomodo por tiempos quirúrgicos.

La instrumentista le proporciona al cirujano vaso de asepsia con isodine solución y con torunda de gasa y pinza de anillos para realizar antisepsia de región operatoria. La instrumentista proporciona campo al tercio y triangular , pinza de campo, sabana de pie, tres campos sencillos y dos pinzas de campo. El cirujano coloca gorro y delimita campo operatorio se cierra circuito estéril . El instrumentista proporciona blefarostato y gasa doblada el cirujano separa párpados y da posición al separador con ayuda de gasa en el ángulo externo del ojo, la instrumentista le proporciona jeringa desechable de 10 ml., Con solución Hartman y cánula oftálmica, el cirujano irriga la cornea, con tijera wescot y pinza Hartman bishop con dientes e hisopo húmedo peinado el cirujano realiza perito mía de base fornix de Meridiano de la una a meridiano de la cinco con hisopo diseca conjuntiva y tenón hasta visualizar músculo recto externo, la instrumentista proporciona gancho de estrabismo, tijera wescot y pinza Hartman bishop, el cirujano localiza músculo recto externo del sitio de inserción, con compás castro viejo con graduación 5.5 se realiza medición para retroimplante, la instrumentista proporciona porta agujas castro viejo y pinza Hartman bishop sin dientes, el cirujano retoma sutura de vicryl 6/0 para músculo recto externo referido y realiza un retroimplante de 9mm. del Limbo con tijera wescot corta cabos de sutura con porta agujas castro viejo y vicryl 7/0 montado y pinza Hartman bishop sin dientes sutura conjuntiva externa con punto separados, con tijera wescot corta cabos de sutura, la instrumentista proporciona tijera wescot y pinza Hartman bishop e hisopos peinados el cirujano realiza perito mía de meridiano las 7 a meridiano 11 del sector nasal , diseca conjuntiva liberando abundantes fibrosis, se seca sangrado con hisopo para visualizar músculo recto interno con gancho de estrabismo y tijera wescot y pinza bishop con dientes el cirujano localiza y

tracciónа el músculo recto interno liberándolo de adherencias con vicryl 6/0 montado en porta agujas castro viejo con doble armada, pinza Hartman bishop con dientes reimplanta y fija músculo recto interno 5.5mm. del limbo la instrumentista proporciona pinza Hartman bishop sin dientes, tijera wescot el cirujano anuda punto de sutura y corta cabos de sutura, con vicryl 7/0 montado en porta agujas castro viejo pinza Hartman bishop con dientes se inicia sutura de conjuntiva con puntos separados, la instrumentista proporciona pinza Hartman bishop sin dientes, tijera wescot el cirujano anuda sutura y corta cabos de la misma con tijera wescot corta vicryl de rienda y lo retira. La enfermera proporciona gotas de prednisolona, cloranfenicol gotas y ungüento el cirujano separa digitalmente párpados para administración de medicamento, la instrumentista proporciona gasa seca y apósito se limpia y seca exceso de isodine y se coloca apósito fijándolo con micropore.

Se da por concluido acto quirúrgico se rompe circuito estéril, se retira la ropa e instrumental utilizado dándole cuidados posteriores a su huso y entrego al servicio de Ceye. Se prepara la sala para el siguiente procedimiento quirúrgico.

Observaciones:
Durante el transoperatorio se mantiene irrigada la córnea con solución Hartman en jeringa de 10 ml., con cánulas oftalmológicas y se proporciona hisopos húmedos peinados, los necesarios.

PTERIGION

Objetivo: Corregir al máximo el tejido degenerativo de la conjuntiva así mismo mejorando el defecto estético.

Concepto:

Tejido elástico degenerativo lentamente desde la conjuntiva hacia la parte anterior de la córnea, de comportamiento benigno.

Etiología:

El pterigión se origina como respuesta a la irrigación de pinguecula : nódulo elástico benigno heredado.
Los factores que favorecen el progreso del pterigión son: los ambientales como clima seco y rayos solares, factores irritativos como gases, vapores y substancias químicas.
El pterigión es mas frecuente en ancianos que en jóvenes.

Fisiopatología:

El nódulo heredado degenera el tejido conjuntival y empieza a proliferar en forma anormal y de manera progresiva invade cada vez mas córnea, siendo favorecido éste proceso por el calor seco, sol y factores irritativos del ambiente.

Cuadro clínico:

Puede ser asintomático, dependiendo del tamaño puede dar una inducción progresiva al astigmatismo, interferencia con la visión, interferencia en la motilidad del globo ocular inflamación periódica, lagrimeo, enrojecimiento y sensación de cuerpo extraño.

Diagnostico:

Cuadro clínico .
Biomicroscopía.

Tratamiento:

Quirúrgico.
Extirpación del pterigión.
Radiación.
Tipo Beta terapia.

Pronostico:

Bueno para la vida y la función.

Manejo pre-operatorio:

Ayuno, exámenes de laboratorio: B.H. , Q.S. , T.P.
Estudios oftalmoscópicos los necesarios según lo avanzado de la patología.

Posición:

Decúbito dorsal.

Tipo de anestesia:

Local.

Instrumental:

Equipo básico de oftalmología**.**
Equipo de Pterigión.
Aditamentos de lámpara.
Cauterio d bronce.
Equipo de asepsia.

Suturas:

Seda 7/0

Material de consumo:

Guantes de diferente numero.
Gasa 10 x 10.
Gasa de 7x5.
Aplicadores.
Torundas.
Hoja de bisturí # 15.
Jeringas de 5 y 3 cc.
Agujas desechables # 20 y 25.

Ropa:

A y B.

Medicamento:

Xylocaina al 2 %.
Cloranfenicol ungüento.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
EXTIRPACIÓN DE PTERIGIÓN

Previo lavado mecánico y quirúrgico de manos y secado de las mismas, procedo a vestirme con bata estéril y calzarme con guantes con técnica cerrada, visto mesa riñón y de mayo, visto el cirujano y ayudante, lavo instrumental con solución salina, lo seco y acomodo por tiempos quirúrgicos.

La enfermera quirúrgica proporciona dos campos uno triangular y otro en 3/4, el cirujano coloca el turbante al paciente, y proporciona sabana simple y tres pinza de erinas, el cirujano delimita el área quirúrgica y fija los campos, la instrumentista proporciona jeringa con aguja numero 26 y colirio de propacaína, el cirujano realiza anestesia tópica, con blefarostato castro viejo se realiza separación de párpados, la instrumentista proporciona perilla con solución fisiológica, gasa e hisopo húmedo, el cirujano realiza lavado de saco conjuntival, la instrumentista proporciona mango de bisturí numero 3 Bard Parker con hoja numero 115, el cirujano realiza queratectomía lamelar toma la cabeza de pterigión y diseca con tijera se Stevens y pinza de disección con dientes, realiza corte y disección de tejido fibroso con seda numero 7/0 montada en porta agujas de castro viejo pinza de disección sin dientes y tijeras de iris el cirujano realiza sutura de conjuntiva y corta cabos de sutura, con gasa húmeda se realiza limpieza del área ocular, se plica ungüento de cloranfenicol en forma tópica se colocan aposito con gasa dobladas y se fija con micropore.

COMPLICACIONES:

Perforación corneal
Perforación escleral.
Escleritis.
Sangrado.
Recidiva.
Glaucoma.

MANEJO POS-OPERATORIO.

Tres semanas de veta terapia con el fin de que disminuya la formación de tejido en sitio de pterigión.

Cloranfenicol ungüento.
Anti-inflamatorios sub-conjuntivales

TRABECULECTOMIA

Objetivo:

Disminuir el dolor, mejorar la visión al descomprimir la retina y los vasos sanguíneos del interior del ojo.

Concepto:

Es un procedimiento quirúrgico de filtrado o drenaje, y disminuye la presión intraocular al crear un canal nuevo para la salida del humor acuoso entre la cámara anterior y el espacio bajo la cápsula de tenón.

Posición:

Decúbito dorsal.

Tipo de Anestesia:

Local.

Instrumental:

Equipo de glaucoma.
Separadores jaffe 2
Pinzas 0.12
Tijeras Wescott.
Trabeculótomo.
Cuchillete de Wheeler o de Ziegler.
Tijeras Vannas.
Pinzas Jaffe para hilos.
Porta agujas Castro viejo fino.
Pinzas de mosco rectas 2.

Suturas:

Seda Atraumática 4/0
Vicryl 7/0.
Nylon 10/0.

Material de consumo:

Solución Salina Balanceada.
Gasa 10x10.
Jeringas de Insulina.
Equipo de Venopack.
Agujas de 20 y de 22.
Hisopos.
Micropore.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA.
(TRABECULECTOMÍA)

Previo lavado mecánico y quirúrgico de manos, y secado de las mismas. Procedo a vestirme con bata estéril y calzarme guantes con técnica cerrada, visto mesa riñón y de mayo, visto al cirujano y ayudante. Acomodo el Instrumental por tiempos quirúrgicos.

La instrumentista proporciona al cirujano vaso de asepsia con torunda de gasa y pinza de anillos. Se proporciona isodine solución por la enfermera circulante el cirujano realiza antisepsia de la región operatoria. La instrumentista proporciona campo al tercio y triangular pinzas de campo y sabana de pies tres campos sencillos coloca turbante y se delimita campo operatorio. Se cierra circuito estéril.

La enfermera instrumentista proporciona blefarostato de castro viejo, jeringa con solución salina balanceada y gasa el cirujano realiza separación de párpados y lavado de fondo de saco conjuntivas, irrigación y secado. Con seda 4/0 montada en pinza halsted, pinza bishop con dientes el cirujano realiza recección del músculo recto superior. La instrumentista proporciona tijera Wescott y pinza bishop Hartman, cuchillete corneal de took y electro cauterio el cirujano realiza perito mía conjuntival a 5mm. De la base del limbo en los meridianos 12 y 1, de la base del limbo, limpieza escleral, hemostasia de vasos sangrantes. Con hisopos húmedos se seca el sangrado.

La enfermera instrumentista proporciona bisturí bard parker con hoja núm.15 el cirujano realiza tallado del rectángulo escleral con base en el limbo. Y con hoja núm. 11 realiza penetración a cámara anterior por vía corneal debajo del colgajo escleral. La enfermera proporciona tijeras vannas y pinza de disección colibrí para resección de fragmentos corneoescleral que incluye al trabéculo y tridectomía basal periférica. Con nylon 10/0 montado en porta agujas de microcirugía de castro viejo, pinza de disección colibrí y tijera de iris. El cirujano sutura el colgajo escleral, corte de cabos de sutura. Realiza súrgete conjuntival y corte de cabos de sutura. Con solución salina balanceada con cánula de irrigación. Se realiza limpieza del área quirúrgica. En jeringa de 3cc con aguja núm. 25, con .5 ml de Dexametazona y .5 ml de Gentamicina. Se realiza aplicación de antibiótico y anti inflamatorio en piso de orbita. Se coloca aposito ocular con gasa doblada y se fija con micropore. Y se da por terminado acto quirúrgico.

Complicaciones:

Infección.
Dehiscencia de herida.
Catarata
Hipotonía ocular.

Manejo pos-operatorio:

Reposo absoluto por 24 horas
Oclusión compresiva.
Midriáticos.
Prednisolona.
Cloranfenicol, tópicos.

DESPRENDIMIENTO DE RETINA

Objetivo:

Colocación de la retina en su posición normal por medio de cerclaje, criopexia y drenaje. Esperando buena evolución del procedimiento. Y que se mejore la visión.

Concepto:

Es la separación de la retina de la coroides.
Desprendimiento simple es aquel que se debe a la aparición De un orificio en la retina en el cual permite el paso del liquido desde el vítreo y separa la retina el lecho desde atrás.
Y Desprendimiento secundario es cuando la retina es rechazada mecánicamente desde su lecho por contracción del tejido fibroso y del vítreo.

Posición:

Decúbito dorsal con leve trendelemburg invertida.

Tipo de anestesia:

General.

Instrumental:

Equipo de retina
Equipo de asepsia
Electrocauterío

Sutura:

Seda atraumática 4/0
Mersilene 5/0
Vicryl 7/0

Material de consumo:

Jeringas de 20,10,y 3cc.
Agujas de 20 y 25.
Bandas de silastic núm.40 y 240
Gasas 10x10.
Hojas de bisturí núm. 15
Hisopos
Solución Salina Balanceada.
Micropore.

Ropa:

A y B.

Medicamentos:

Dexametazona.
Gentamicina.
Cloranfenicol.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA (DESPRENDIMIENTO DE RETINA)

Previo lavado mecánico y quirúrgico de manos, y secado de las mismas. Procedo a vestirme con bata estéril y calzarme guantes con técnica cerrada, visto mesa riñón y de mayo, visto al cirujano y ayudante. Acomodo el Instrumental por tiempos quirúrgicos.

La instrumentista proporciona campo al tercio y triangular pinza de campo, el cirujano coloca el turbante al paciente, la instrumentista proporciona dos campos en 3/4, dos pinzas de campo sabana de pies, el cirujano delimita el área quirúrgica.

Con seda atraumatica 4/0 cortada a la mitad y montada en pinza halsted, y pinza de disección sin dientes. El cirujano realiza fijación de los párpados superior e inferior, dejándose referida con la pinza halsted al campo. La instrumentista proporciona jeringa de 10cc. e irrigación con S.S.B. y gasa seca. El cirujano realiza lavado de fondo de saco conjuntival. Con tijera wescott y pinza de disección bishop hartman con dientes el cirujano realiza incisión y perilimbotomía en 360 se proporciona tijera de stevens y pinza de disección sin dientes el cirujano profundiza disección de conjuntiva. Con ganchos jamesón se localizan los músculos rectos con seda libre del 0, con un nudo abierto en el extremo refiere los músculos rectos. Con oftalmoscopia indirecta lámpara frontal y lupa se localiza zona del desgarro. La instrumentista proporciona banda de silastic núm. 240 y pinza de disección de joyero se pasa

La banda por debajo de los músculos rectos con mersilene 5/0 montado en porta agujas castro viejo el cirujano realiza fijación de la banda de silastic en zona de ecuador con pinza de joyero y tijeras stevens. Realiza corte de cabos de sutura. Con el tenómetro mide la presión intraocular. Con mango de bisturí bard parker núm. 3 con hoja 15 el cirujano realiza marcación del sitio de drenaje. Con aguja micropoint de vicryl 7/0 se realiza perforación de la esclera para que drene el líquido subretiniano. La instrumentista proporciona dos pinzas de disección sin dientes y pinzas halsted. El cirujano reafirma ajuste de la banda de silastic con tijera de iris realiza corte del sobrante de la banda.

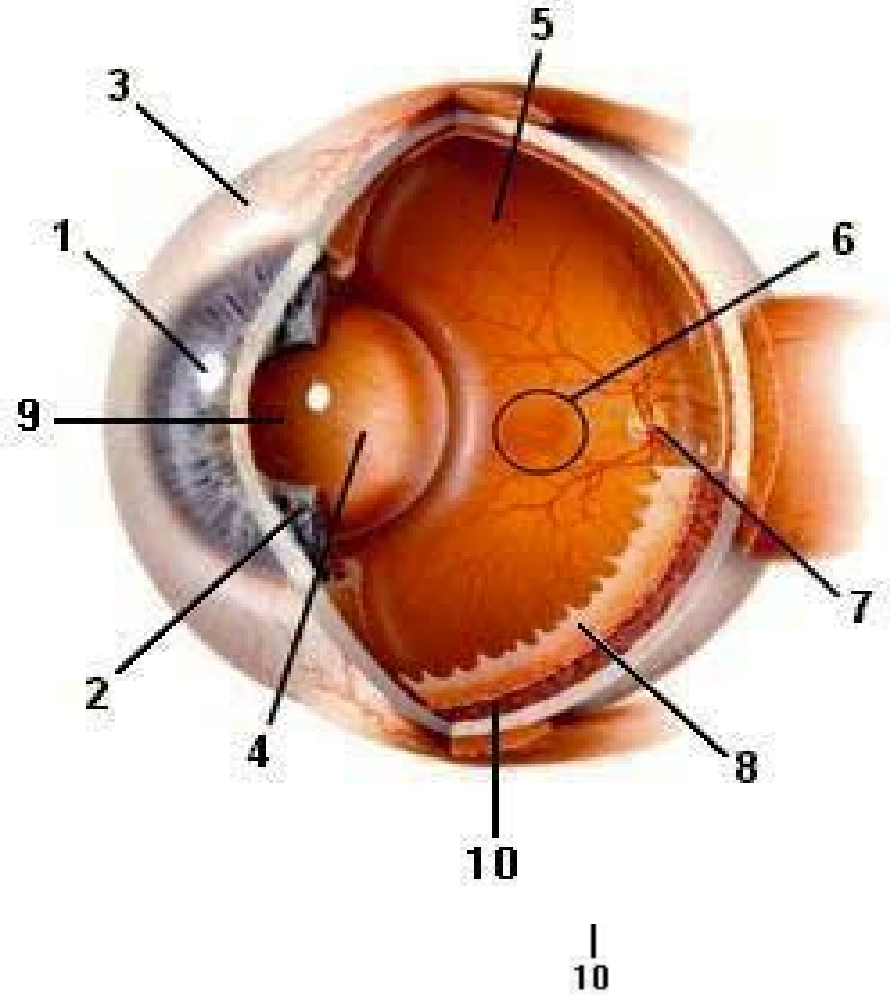
Con vicryl 7/0 montado en porta agujas de barraquera y pinza realiza sutura de conjuntiva y corte de cabos de sutura. La instrumentista proporciona jeringa de 3cc. con aguja núm. 25 con .5ml. de gentamicina y .5ml de dexametazona. El cirujano aplica en piso de la órbita. Con gasa húmeda y seca se realiza limpieza del área operada. Se aplica gotas de cloranfenicol se coloca aposito con gasa dobladas y se fija con micropore. Se da por concluido el acto quirúrgico.

Complicaciones:

Infecciones
Dehiscencia de herida quirúrgica
Rechazo de la banda de silastic.

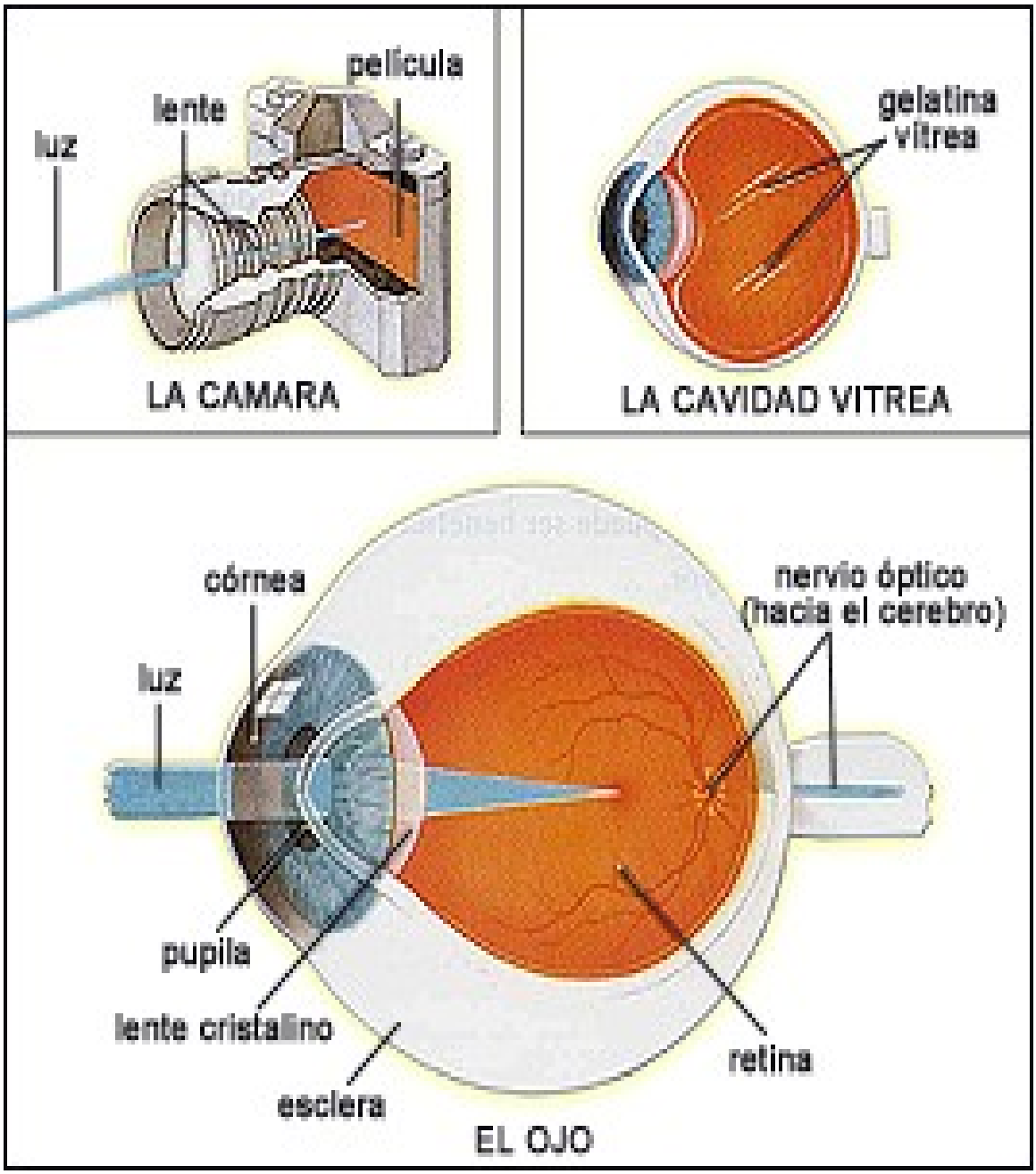
Cuidados pos-operatorios:

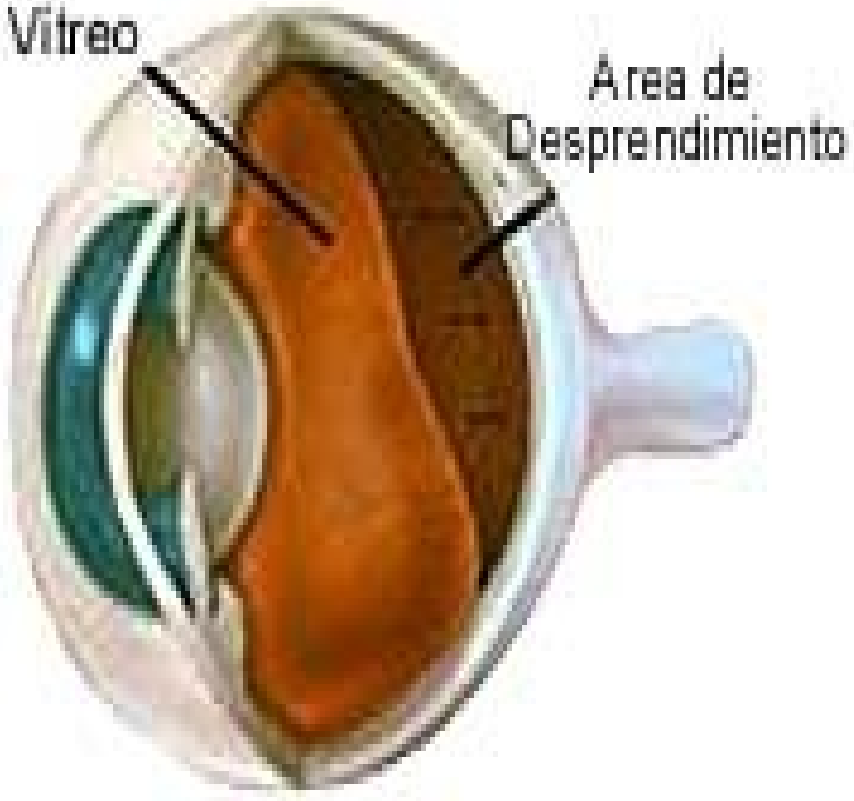
Reposo absoluto.
Antibiótico terapia
Analgésicos.
Analgésicos
Antieméticos.
Cambio de aposito p.r.n.

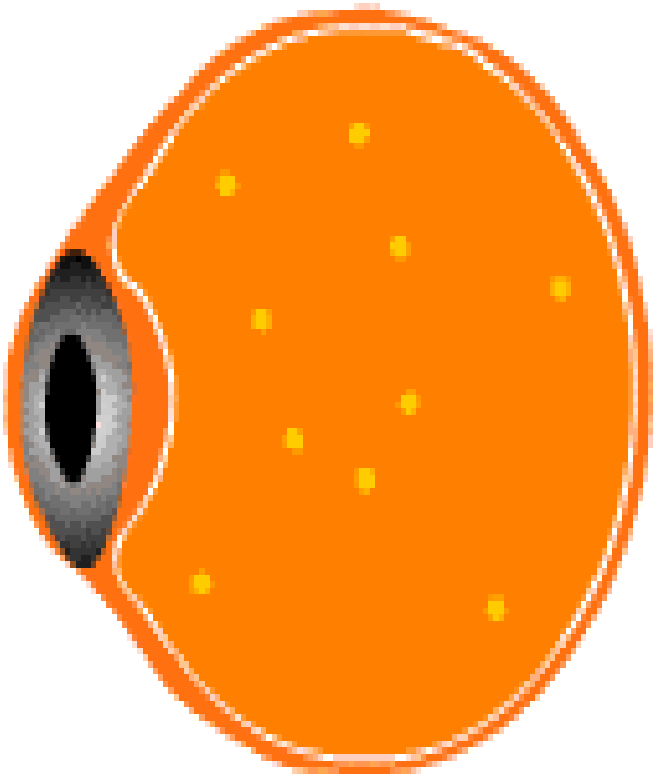


1.- Cornea
2.- Iris
3.- Esclera
4.- Lente
5.- Retina
6.- Mácula
7.- Nervio óptico
8.- Pars plana
9.- Pupila
10.- Coroides

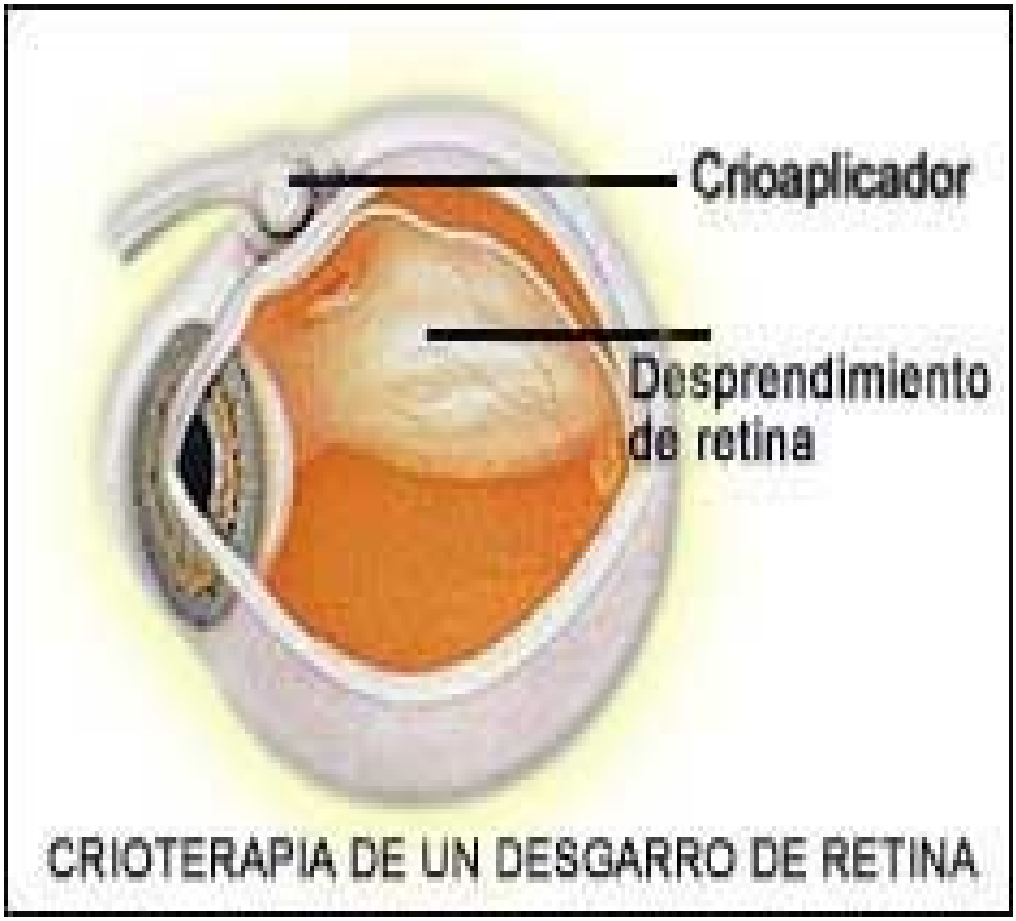
cristalino.


película
lente
luz
LA CAMARA
gelatina vítrea
LA CAVIDAD VITREA
córnea
nervio óptico (hacia el cerebro)
luz
pupila
lente cristalino
esclera
retina
EL OJO

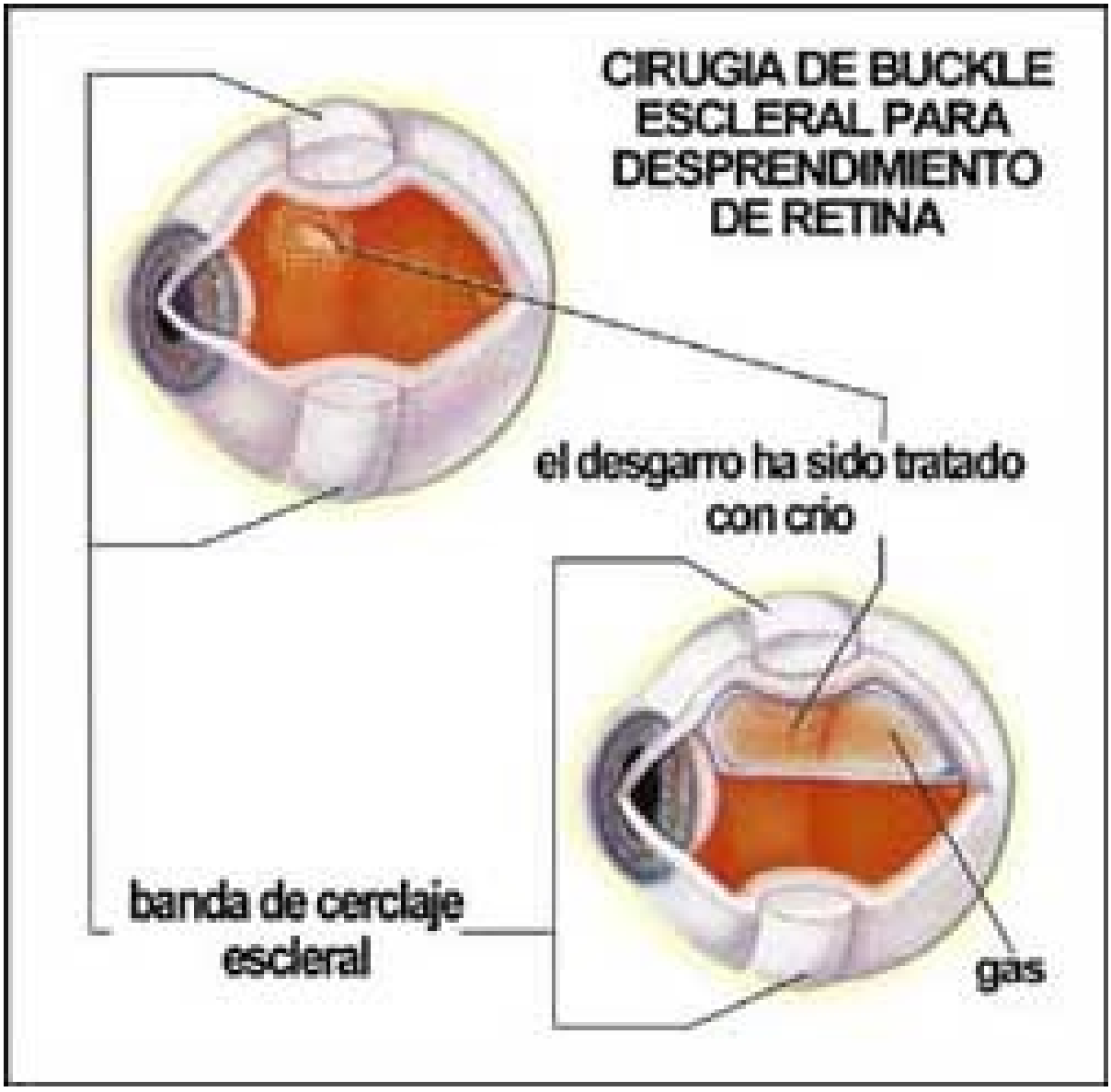

Vitreo
Area de
Desprendimiento

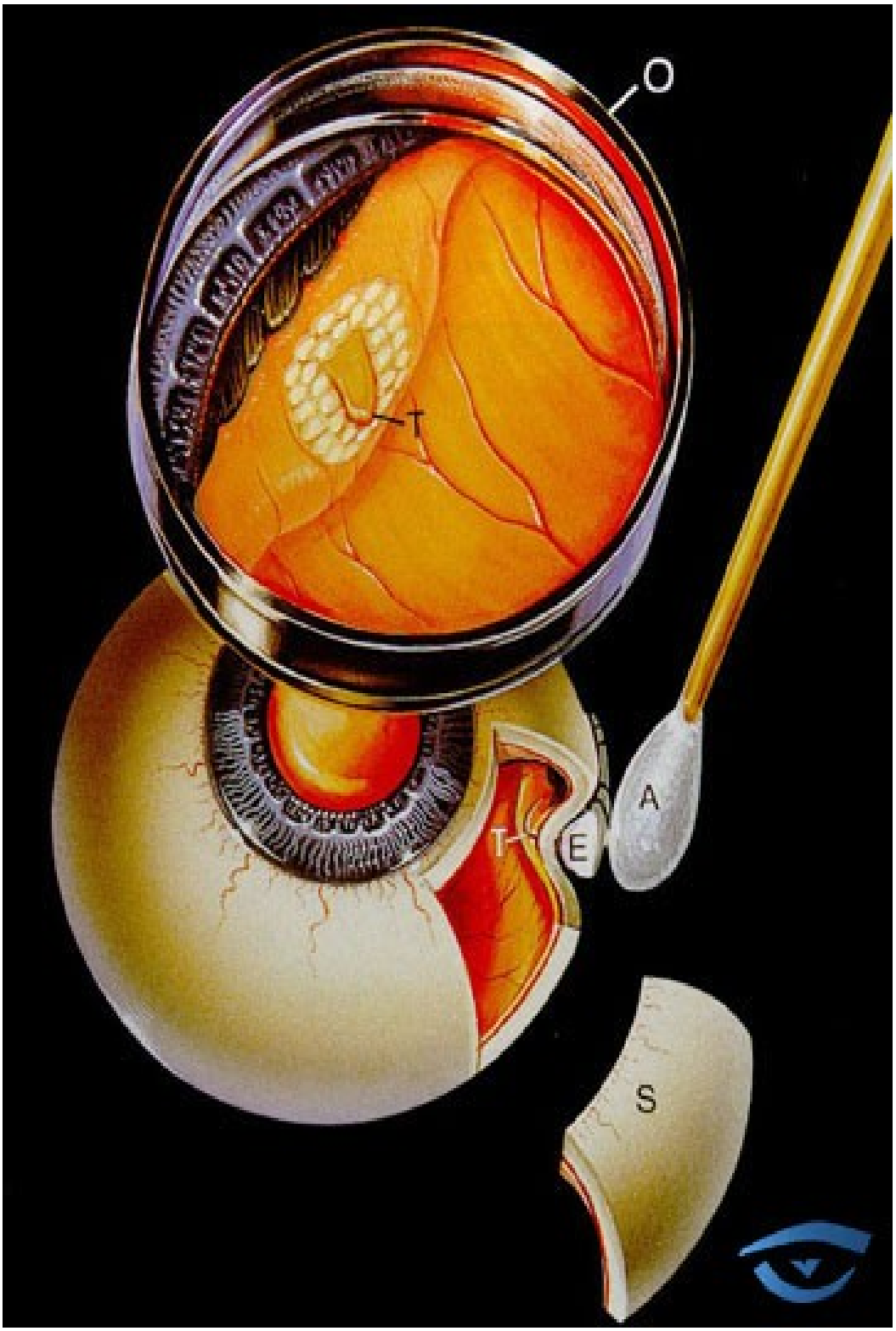


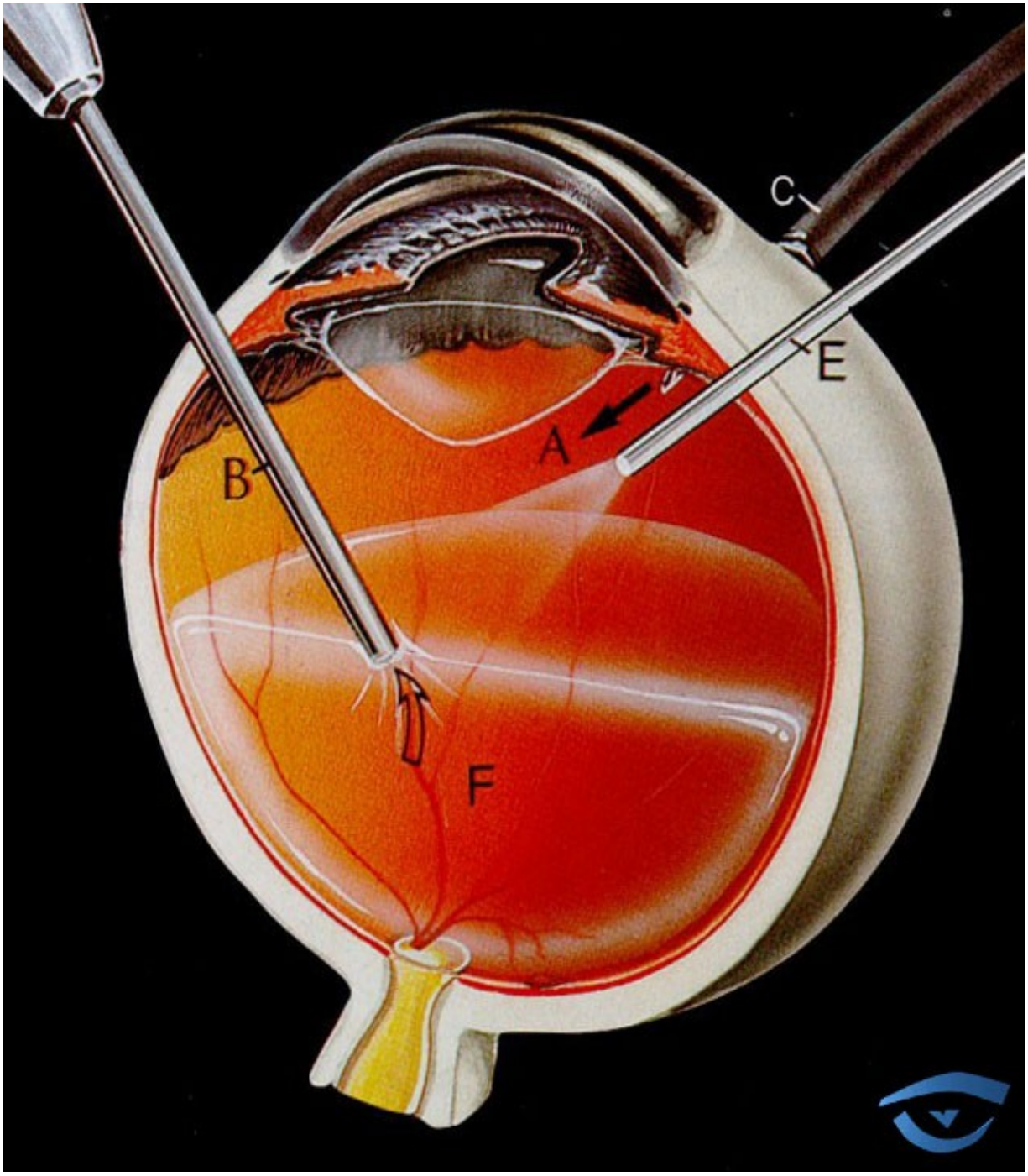


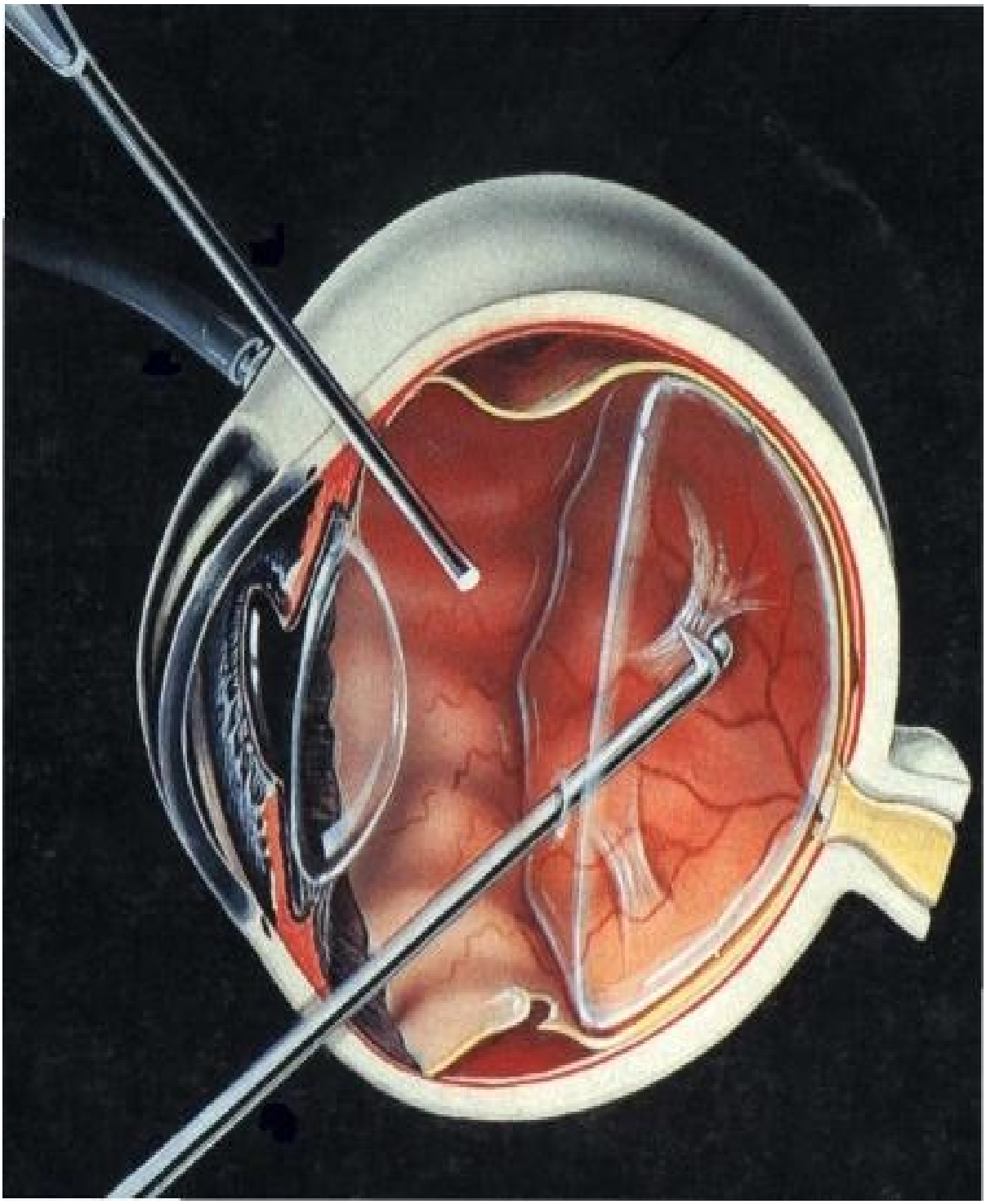


CRIOTERAPIA DE UN DESGARRO DE RETINA


CIRUGIA DE BUCKLE ESCLERAL PARA DESPRENDIMIENTO DE RETINA
el desgarro ha sido tratado con crio
banda de cerclaje escleral
gas


O
T
T
E
A
S


C
E
A
B
F



CIRUGÍA REFRACTIVA
(LASIK)

Objetivo:

Corregir errores visuales mediante la aplicación quirúrgica de láser.

Concepto:

Es un procedimiento quirúrgico que corrige errores de refracción visuales, mediante la aplicación, quirúrgica del láser EXCIMER directamente sobre el estoma corneal.

Posición:

Decúbito dorsal.

Instrumental:

Microqueratomo (platina de 160 y 180 micras).
Anillo corneal 8.5
Marcador corneal.
Anillo corneal 9.5
Blefarostato.
Equipo de pterigión.

Material de consumo:

Solución salina balanceada.
Solución de yodopovidono.
Solución de agua inyectable.
Esponjas oftálmicas
Micropore de 1 pulg.
Micropore de ½ pulg.
Gasas.

Equipos y aparatos:

Sistema láser eximer.
Aparato de solución oftálmico.

CIRUGIA REFRACTIVA (LASIK)

INDICACIONES

I.- Pacientes de 20 a 50 años de edad con defecto visual refractivo estable.

REFRACCIONES

Miopía de 2 a - 12 dioptrías.
Astigmatismos de 1 a 6 dioptrías.
Hipertropías de + 1 a + 5 dioptrías.

CONTRADICCIONES

I.- Infecciones del segmento anterior.
Desprendimiento de retina.
Glaucoma, Queratomo, herpes simple.
Vascularización corneal.
Diabetes, Lactación, y embarazo.

CUIDADOS ESPECIFICOS DE ENFERMERÍA
Cuidados pre -operatorios.

15 días antes de la cirugía dejar de utilizar los lentes de contacto blandos, y un mes antes si son duros.

Verificar que el paciente ingrese al quirófano sin maquillaje y con ropa gruesa térmica, y que lleve consigo los resultados, dos de los estudios de Queratometría, topografía corneal y paquimetría.

CUIDADOS POS- OPERATORIOS

Oclusión del ojo intervenido.
Dar información al paciente sobre síntomas que presentará (lagrimeo, sensación de basura dentro del ojo y ardor.)

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
CIRUGÍA REFRACTIVA (LASIK).

Previo lavado mecánico quirúrgico de manos secado de las mismas, procedo a vestirme con bata estéril y calzarme guantes con técnica cerrada. Visto mesa riñón y de mayo, acomodo instrumental por tiempos quirúrgicos. Visto al personal medico y se da por iniciado el acto quirúrgico, previa calibración y programación del sistema láser, introduciendo datos del paciente, tipos de padecimientos y refracciones.

Se realiza aplicación de gotas de tetracaina oftálmica, se fija el párpado superior con cinta micropore estéril, se coloca separador ocular blefarostato, la instrumentista prepara platinas de 160 a 180 micras el cirujano verifica el centrado del láser auxiliares, efectúan marcación corneal previamente impregnado con azul de metileno proporciona anillo corneal 8.5 o 9.5 ensamblado al succionador oftálmico y presión del pedal, el cirujano realiza fijación del globo ocular, se coloca al microqueratomo la platina de 160 a 180 micras según paquimetría del paciente y ensambla el microqueratomo al anillo corneal, efectúa incisión corneal.

La enfermera retrae el párpado inferior, irriga, con solución salina balanceada, y presiona el pedal del microqueratomo, la enfermera presiona los pedales del succionador y del microqueratomo, el cirujano retira el succionador y el microqueratomo, la instrumentista proporciona espátula y esponja oftálmica, el cirujano levanta el colgalo corneal , se verifican las refracciones que se va a corregir, la enfermera indica a tiempo la aplicación del láser el cirujano coloca el rastreador láser se indican el tiempo transcurrido de aplicación del láser el cirujano aplica el láser excimer, se repara esponja húmeda con solución salina balanceada, y frascos de irrigación con cánula oftálmica calibre 27 el cirujano remueve el residuo de estroma y efectúa recolocación.

La enfermera proporciona esponja oftálmica seca, el cirujano verifica el colgalo corneal y retira el blefarostato, la instrumentista instila antibiótico y anti inflamatorio ocular y efectúa oclusión con gasa.

VITRECTOMIA POSTERIOR

Objetivo:

Evitar la hemorragia del vítreo y eliminar la opacidad m mejorando la visión

Concepto:

Es un procedimiento micro quirúrgico diseñado para extraer opacidades, en el humor vítreo y eliminar tracciones del mismo sobre la retina.

Indicaciones:

La hemorragia del vítreo debida a retinopatía diabética poliferativa, es la causa mas común para indicación de vitrectomia.

Desprendimiento de retina, macular y mixta: por tracción y Regmatógena.

Neovascularización del segmento anterior con opacidad del Segmento posterior.

Contraindicaciones:

En pacientes que no perciben luz.
En infecciones activas parpebrales, corneales y conjuntivales.

Posición:

Decúbito dorsal.

Tipo de anestesia:

General.

Instrumental:

Blefarostato.
Tijeras Wescott.
Compás castro viejo.
Cánula de perfusión larga o mediana.
Porta agujas fino.
Estilete para vitrectomía.
Lente de contacto.
Equipo para cataratas.

Material de consumo:

Hoja de bisturí num. 15.
Solución salina balanceada.
Equipo de venoclisis.
Gasas.
Equipo de vitrectomía con cortador vítreo.
Sonda de endoiluminación calibre 20.
Sonda para endoláser calibre 20.
Multicelulosa al 2%.

Sutura:

Vicryl 7/0.

Equipos y aparatos médicos:

Vitrector con fuente de iluminación.
Electro cauterio.
Microscopio con pedal.
Aparato de endoláser de diodos.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

VITRECTOMÍA POSTERIOR

Previo lavado mecánico quirúrgico de manos secado de las mismas, procedo a vestirme con bata estéril y calzarme guantes con técnica cerrada. Visto mesa riñón y de mayo, acomodo instrumental por tiempos quirúrgicos. Visto al personal medico y se da por iniciado el acto quirúrgico.

La enfermera instrumentista proporciona blefarostato al cirujano y este efectúa abertura palpebral posteriormente la instrumentista proporciona mango de bisturí con hojas num. 15 y tijeras de Wescott y el cirujano realiza incisión conjuntival, se le proporciona estilete para vitrectomía, hace dos escleretomías en las posiciones de las 10 y las 12 del reloj, la instrumentista proporciona compás Castro viejo, estilete para vitrectomía, cánula de perfusión conectada a un equipo de venolisis con solución salina balanceada, el cirujano coloca la cánula de infusión en la esclerótica a 3.5 mm. por detrás del limbo, la enfermera quirúrgica proporciona al cirujano lente de contacto y microscopio, metilcelulosa a 2% coloca una lente de contacto sobre la cornea, y aplica lubricante sobre la lente, se le proporciona cortador vítreo y sonda de endoiluminación , observa a través de la lente e inserta el cortador vítreo y el tubo de endoiluminación a través de las dos escleroctomías; la instrumentista vigila que la llave de paso del equipo de venoclisis esté abierta totalmente, el cirujano extrae el vítreo central y todas las opacidades y reemplaza lo extraído con solución salina balanceada, posteriormente, la instrumentista proporciona sonda para endoláser calibre 20, el cirujano en caso necesario realiza endofotocoagulación para eliminar e impedir el crecimiento de neovasos, se realiza cierre de las escleroctomías con vicryl calibre 7-0 en porta agujas fino, posteriormente se coloca parche ocular y se da por terminado procedimiento quirúrgico.

EXTRACCIÓN DE CATARATA Y COLOCACIÓN DE LENTE INTRAOCULAR

Objetivo:

Mejorar la visión mediante la colocación del lente intraocular.

Concepto:

Esta técnica consiste en la extirpación de un cristalino opaco y la cápsula anterior, dejando intacta la cápsula posterior para colocar un lente intraocular, en la bolsa formada por la cápsula posterior. Se hace una capsulotomía anterior para Evitar opacidad de la misma en el pos operatorio tardío.

Indicaciones:

Reducción de la videza visual.

Cuando la presencia de la catarata afecta en forma adversa la salud del ojo, ejem. Glaucoma, facolítico y retinopatía día bética.

Estética. Para recuperar una pupila negra.

Contraindicaciones:

Mal estado general del paciente.
Desprendimiento de retina y coroides.

Posición:

Decúbito dorsal.

Tipo de anestesia:

Bloqueo retrovulbar.

Instrumental:

Equipo para catarata.

Suturas:

Seda 5/0.
Vicryl 7/0.
Nylon 10/0.

Material de consumo:

Solución salina balanceada.
Jeringas de 5 y de 3 cc.
Jeringas de insulina.
Electro cauterio.
Hisopos.
Gasas.
Equipo de venoclisis.
Hoja de bisturí num. 15 y 11.
Agujas num. 20 y 25.
Micro esponjas.
Micropore.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
EXTRACCIÓN DE CATARATA Y COLOCACIÓN DE LENTE INTRAOCULAR

Previo lavado mecánico quirúrgico de manos secado de las mismas, procedo a vestirme con bata estéril y calzarme guantes con técnica cerrada. Visto mesa riñón y de mayo, acomodo instrumental por tiempos quirúrgicos. Visto al personal medico y se da por iniciado el acto quirúrgico.

La instrumentista proporciona al cirujano 4 torundas de gasa y pinza de anillo, con isodine solución directo en las gasas , y se realiza antisepsia de la región operatoria.

Se realiza lavado de guantes, con ayuda de la circulante y se los secan con gasa o con un campo sencillo. La instrumentista proporciona un campo al tercio y triangular pinza de campo, el cirujano viste al paciente delimitando el área operatoria y fija con pinzas. Se cierra circuito estéril.

Con blefarostato y una gasa doblada, se separan párpados y da posición al blefarostato con ayuda de la gasa en el ángulo externo del ojo.

Con solución Hartman en jeringa de 10 cm. Con cánula oftalmológica e hisopos húmedos peinados se realiza aseo de base de las pestañas y fondo de saco conjuntivas.

La instrumentista proporciona vicryl 6 0 con corte de una aguja montada en porta gujas de castro viejo, pinza Hartmán bishop con dientes y pinza de mosco curva el cirujano coloca riendas en el músculo recto superior y lo fija al campo con la pinza de mosco. Realiza peri otomía superior perilimbica de 180 con tijera de Wescot y pinza Hartman bishop con dientes , se calienta cauterio con torunda alcoholada y se realiza cauterización de vasos sangrantes para realizar hemostasia, o a su vez puede ser con cauterio manual que funciona por medio de pilas y se esteriliza en gas. Con hoja de bisturí # 15 montada en mango de bisturí Bard Parker # 3 se realiza surco esclerocorneal. Con jeringa de insulina con aguja cargada con 2 décimas de solución y porta gujas castro viejo. Se adapta como quisquitomo montado en jeringa de insulina. Con jeringa de insulina con aguja recta se realiza parasíntesis con hoja de bisturí # 11 montada en mango de bisturí Bard Parker # 3 se amplia incisión de parasíntesis con una jeringa con healón y cánula oftálmica se reforma la cámara anterior con la jeringa de insulina con quisquitomo se realiza capsulotomía, con jeringa de 5 cm.

Con solución Hartman con cánula oftálmica se realiza hidrodisección con tijera corneal y pinza de colibrí se hace rotación del núcleo del cristalino, ampliación de la incisión esclerocorneal con asa de lewis y gancho de estrabismo se realiza luxación y extracción del núcleo del cristalino. Con Nylon 10/0 cortado a la mitad montado en porta gujas Nenedle y pinza colibrí se inicia sutura con 2 puntos separados a cada lado de la herida esclerocorneal, introduce punto de sutura a tejido corneal con pinza Lester anuda punto de sutura. Se repiten los mismos pasos hasta a completar los cuatro puntos de sutura.

Con cánula de doble vía con jeringa de insulina en un extremo y venopack purgado con solución Hartman en otro se realiza extracción de restos corticales y capsulares mediante irrigación por succión Jeringa con Healón y cánula oftálmica se reforma cámara anterior con pinza Mc pearson, pinza colibrí, lente intraocular en su estuche con una gota de agua para mejor localización se toma el lente y lo coloca en cámara posterior. Con Gancho Sin ski rota el lente y lo acomoda, con Nylon 10/0 montado en porta gujas Nenedle y pinza colibrí se reinicia sutura de herida esclerocorneal ,introduce punto de sutura a tejido corneal con pinza Lester anuda sutura con tijera corneal corta cabos de sutura. Se repite el mismo procedimiento hasta terminar de cerrar herida quirúrgica.

Con tijera Wescot corta vicryl de rienda de recto superior y la retira con pinza de mosco. En jeringa de insulina con Amicacina, dexametasona y xilocaina al 2% infiltra medicamento subconjuntival, con gasa húmeda, y gasa seca se limpia y se seca el exceso de isodine. Con aposito de gasa y micropore se coloca apósito monocular oclusivo y lo fija.

Se da por concluido el acto quirúrgico, se rompe circuito estéril, se retira la ropa e instrumental utilizado, dándole cuidados posteriores a su uso y se entrega al servicio de ceye. Se prepara la sala para el siguiente procedimiento quirúrgico.

OBSERVACIONES

Durante todo el procedimiento quirúrgico se proporcionan hisopos húmedos peinados, además se mantiene irrigada la córnea con solución Hartman en jeringa de 10 ml. Con cánula oftalmológica.

TRANSPLANTE CORNEA

Objetivo:

Brindar la oportunidad de la visión, por medio del transplante de cornea, donado por otra persona.

Concepto:

Es el procedimiento quirúrgico que consiste en remplazar el Espesor total de la córnea, con una córnea donante.

Etiología:

Traumatismo.
Defectos congénitos.

Indicaciones:

Heridas corneales, queratocono, leucomas congénitos degeración corneal y otras distrofias corneales.

Posición:

Decúbito dorsal.

Tipo de anestesia:

General.

Instrumental:

Equipo especial de transplante de cornea.
Equipo básico de oftalmología.

Ropa:

A y B.

Material de consumo:

Cornea donadora.
Solución salina balanceada.
Jeringas de 10, 5 y 3 cc.
Jeringas de insulina
Hisopos.
Gasas.
Agujas de 20 y 22.
Hoja de bisturí num. 15 y 11.
Healón.

Suturas:

Seda 4/0.
Nylon 10/0.

Aparatos:

Microscopio.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
TRANSPLANTE CORNEA

Previo lavado mecánico quirúrgico de manos secado de las mismas, procedo a vestirme con bata estéril y calzarme guantes con técnica cerrada. Visto mesa riñón y de mayo, acomodo instrumental por tiempos quirúrgicos. Visto al personal medico y se da por iniciado el acto quirúrgico.

La enfermera instrumentista proporciona campo al tercio y triangular, pinza de campo, el cirujano coloca turbante y fijación del mismo se proporcionan dos campos, sabanas de pies y tres pinzas campo el cirujano delimita el área quirúrgica la enfermera proporciona blefarostato de Mc. Neil Goldman se separan párpados con seda montada 4/0 en pinza Halsted, pinza de disección con dientes y tijeras de iris el cirujano realiza fijación de anillo y corte d e cabo de sutura, con seda 4/0 montada en pinza Halsted pinza de disección con dientes el cirujano fija el músculo superior, con trepano corneal y pinza de disección 0.12, el cirujano realiza trepanación del botón sobre el block de teflón. Manteniéndolo húmedo en el mismo medo de conservación. La enfermera proporciona trepano de succión, el cirujano realiza trepanación del botón receptor, la instrumentista proporciona Healón, el cual se aplica y mantendrá formada la cámara, la enfermera proporciona tijeras castro viejo corneales izquierda y derecha, pinza de disección fina 0.12, el cirujano profundiza y prolonga el corte del córnea, la instrumentista proporciona nylon 10/0 montado en porta agujas de microcirugía pinza de disección 0.12, el cirujano retira el botón corneal y se coloca el botón donador fijándose en cuatro meridianos, con hoja de bisturí num. 11 se retira primeros puntos de fijación ,la enfermera proporciona solución S.S.B. en jeringa y gasas seca, el cirujano irriga y realiza limpieza del área operada. La enfermera proporciona cloranfenicol gotas aplicándose de antibiótico tópico, colocación de aposito realizando oclusión del globo ocular, fijándose con micropore. Dando pore terminado el acto quirúrgico.

Complicaciones:

Hemorragia.
Infección.
Rechazo al transplante.

Cuidados pos operatorios:

Reposo absoluto.
Evitar golpes.
Anti inflamatorios.
Anti biótico terapia.
Aposito ocular por 46 horas.

EVISCERACIÓN

Objetivo:

Permitir la inserción de una prótesis, lo cual ayuda a que el trauma psicológico disminuya en el paciente.

Concepto:

Consiste en una técnica quirúrgica en la cual se lleva a cabo la remoción del contenido globo ocular, dejando intacta la clerótica externa, los músculos y nervio óptico para permi tir la inserción de una prótesis.

Etiología:

Destrucción del globo ocular por traumatismo, infecciones, Enfermedades como glaucoma terminal, buftalmos y secuelas de traumatismo ocular.

Posición:

Decúbito dorsal con leve tendelemburg invertida.

Anestesia:

General.

Instrumental:

Equipo de evisceración.
Básico para cirugía de oftalmo.
Electro cauterio.

Ropa:

A y B.

Material de consumo:

Prótesis.
Conformador de plástico.
Hoja de bisturí num. 15 y 11.
Solución salina balanceada.
Gasas.
Hisopos.
Jeringas de 5 y 3 cc.
Jeringas de insulin
Agujas desechables 20 y 22.

Suturas:

Seda 4/0.
Vicryl 7/0 y 8/0.
Nylon 10/0.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
EVISCERACIÓN

Previo lavado mecánico quirúrgico de manos secado de las mismas, procedo a vestirme con bata estéril y calzarme guantes con técnica cerrada. Visto mesa riñón y de mayo, acomodo instrumental por tiempos quirúrgicos. Visto al personal medico y se da por iniciado el acto quirúrgico.

La enfermera quirúrgica proporciona campo al tercio y triangular, pinza de campo, el cirujano coloca el turbante, la enfermera proporciona dos campos al tercio y sabanas al pie y tres pinzas de campo, el cirujano delimita el área quirúrgica y fijación de los mismos, la enfermera proporciona blefarostato el cirujano realiza apertura palpebral, la enfermera proporciona irrigación con solución salina balanceada, el cirujano realiza lavado de fondo de saco conjuntival. La instrumentista proporciona tijeras wescott y pinza de disección con dientes, el cirujano efectúa disección de conjuntiva, y perito mía de 360 grados, la enfermera proporciona mango tres con hoja de bisturí num. 15 y pinza de disección fina con dientes, el cirujano marca el surco esclerocorneal la enfermera proporciona mango de bisturí con hoja num. 12 y pinza de disección fina con dientes, el cirujano remueve la cornea en cámara anterior la instrumentista proporciona tijera corneal castro viejo y pinza de disección fina con dientes el cirujano efectúa disección del contenido del globo ocular ,la enfermera proporciona pinza de disección fina y cucharilla el cirujano remueve el demanente de coroides del contenido del globo ocular, la instrumentista proporciona mini torunda montada en pinza de mosco el cirujano realiza legrado de esclera y hemostasia por compresión, la instrumentista proporciona irrigación con solución S.S.B. el cirujano realiza lavado de fondo escleral y revisión del mismo la instrumentista proporciona la prótesis dentro del introductor de esferas el cirujano coloca la prótesis la instrumentista proporciona nylon 10/0 montado en porta agujas castro viejo y pinza de disección fina con dientes, el cirujano realiza cierre de tenón de surco esclerocorneal, la instrumentista proporciona vicryl 7/0 en porta agujas castro viejo el cirujano realiza cierre de conjuntiva en jeringa de tres con aguja num. 25 y .5 ml. de gentamicina y .5 de dexamentazona el cirujano lo aplica en el piso de la orbita, se coloca ungüento oftálmico y parche ocular con gasa fijándose con micropore. Dando por terminado acto quirúrgico.

Complicaciones:

Infección.
Dehiscencia de la herida quirúrgica..

Manejo pos operatorio:

Antibióticos.
Anti inflamatorios.
Oclusión.
Medidas higiénicas.

ENUCLEACIÓN

Objetivo:

Colocar una prótesis con fines estéticos, lo cual ayuda a que el trauma psicológico disminuya.

Concepto:

Extracción del globo ocular completa con sección de sus músculos accesorios (se aplica prótesis).

Etiología:

Se indica cuando el globo ocular no tiene función visual o compromete la vida del paciente; en retinoblastomas, melanoma coroideo heridas esclerocorneales amplias con exposición uveal.

Posición:

Decúbito dorsal.

Anestesia:

General.

Instrumental:

Set básico de oftalmología.
Complemento de enucleación.
Electro cauterio

Ropa:

A y B

Material de consumo:

Prótesis.
Gasas.
Hisopos.
Jeringas de 5 y de 3.
Jeringas de insulina.
Hojas de bisturí 15 y 11.
Agujas desechables 20 y 26.
Equipo de venoclisis.
S.S.B.

Sutura:

Seda 4/0.
Vicryl 6/0 y 7/0.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
ENUCLEACIÓN.

Previo lavado mecánico quirúrgico de manos secado de las mismas, procedo a vestirme con bata estéril y calzarme guantes con técnica cerrada. Visto mesa riñón y de mayo, acomodo instrumental por tiempos quirúrgicos. Visto al personal medico y se da por iniciado el acto quirúrgico.

La enfermera quirúrgica proporciona campo al tercio y triangular, pinza de campo, el cirujano coloca el turbante, la enfermera proporciona dos campos al tercio y sabanas al pie y tres pinzas de campo, el cirujano delimita el área quirúrgica y fijación de los mismos, la instrumentista proporciona pinza Halster seda 4/0 pinza de disección bishop con dientes el cirujano coloca riendas palpebrales y fijación de los mismos al campo la instrumentista proporciona irrigación con solución salina alanceada, el cirujano realiza lavado de saco conjuntival, con tijera de Wescott y pinza de disección bishop sin dientes se realiza perilimbotomía a 360 grados con tijeras Stevens y pinza bishop sin dientes se hace disección conjuntival, con ganchos Jamenson porta agujas castro viejo con vicryl 6/0 tijera Wescott se toman los músculos rectos sutura y corte delos mismos. Refiriéndolos, la enfermera proporciona ganchos de estrabismo de Von Graffe el cirujano realiza disección de músculos oblicuos, se efectúa pinzamiento del óptico en 8 meridianos con pinza Halsted y con seda 4/0 y pinza bishop con dientes el cirujano coloca las riendas esclerales en tendones de músculos rectos horizontales la enfermera proporciona cucharilla de Willis cirujano efectúa corte e nervio óptico, extracción del globo ocular, haciendo Hemostasia y compresión durante 5 minutos en porta agujas de castro viejo sin dientes efectúa unión de músculos rectos con sutura de referencia, la instrumentista proporciona vicryl 7/0 montado en porta agujas de castro viejo, pinza de disección fina con dientes y tijeras de iris, el cirujano efectúa sutura conjuntival con súrgete continuo, corte de cabos de sutura con gasa húmeda y seca se limpia el área operada se realiza colocación de apósito ocular con gasa doblada y fijación con micropore. Se da por terminado acto quirúrgico.

Complicaciones:

Infección.
Dehiscencia de herida quirúrgica.

Manejo pos operatorio:

Antibióticos.
Anti inflamatorios.
Oclusión.
Analgésicos.
Reposo absoluto.

CHALAZIÓN

Objetivo:

Debridar al máximo la glándula para evitar una posible infección (mejorar la estética).

Concepto:

Es el quiste de una glándula de meibonio, que adopta la forma de una bolita dura e indolora en el párpado como consecuencia de infección crónica de dicha glándula cuando se ob tura su orificio de desembocadura en el borde palpebral.

Etiología:

Obstrucción y acumulación de la glándula de meibonio pro-
Produciendo una infección. (estafilococo).

Posición:

Decúbito dorsal.

Anestesia:

Local.

Instrumental:

Equipo de chalazión.

Ropa:

Campo hendido.
Equipo C.

Material de consumo:

Hoja de bisturí num. 15
Jeringa de 3 cc.
Jeringa de insulina.
Aguja 20 y 22.
Hisopos.
Gasas.
Cloranfenicol ungüento.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
CHALAZIÓN

Previo lavado mecánico quirúrgico de manos secado de las mismas, procedo a vestirme con bata y guantes estériles.

La enfermera quirúrgica proporciona campo al tercio triangular y pinza de campo, el cirujano coloca turbante y otro en la cabecera, se coloca campos hendido para delimitar área quirúrgica con jeringa de 3 aguja de insulina y xilocaína al 2% y gasa seca el cirujano infiltra el borde del párpado afectado, secando el área húmeda, la instrumentista proporciona pinza de chalazión de lámpert, se coloca para delimitar la tumoración con mango de bisturí Bard parker num. 3 con hoja 15 se efectúa incisión térmica en el borde del párpado e incisión vertical conjuntival. Con cucharilla para chalazión o legra el cirujano realiza curetaje de chalazión hasta quedar limpia la cavidad. La instrumentista proporciona tijera de Wescott y pinza de disección bishop con dientes, el cirujano realiza recepción de la cápsula, se retira pinza de chalazión y se hace compresión con gasa seca por tres minutos. Se da por terminado acto quirúrgico.

DACRIOCISTORINOSTOMIA

Objetivo:

Obtener buena premiabilidad del conducto lagrimal.

Concepto:

Operación para drenar el conducto lagrimal hacia la nariz cuando esta obstruido el conducto nasolagrimal, construyendose un nuevo sistema de drenaje de las lagrimas.

Etiología:

En las dacriocistitis agudas el agente infeccioso mas frecuente es estafilococo beta hemolítico.
En la dacriocistitis crónica el estreptococo pneumoinae es el organismo predominante.

Cuadro clínico:

Lagrimeo y secreción en las formas agudas existe inflamación, dolor e hiperestesia en el área del sacro lagrimal al pre sionarlo.
En la forma crónica, el único signo suele ser el lagrimeo por lo general al exprimir el saco lagrimal sale de este un material mucoide del cuál se puede mandar un frotis a estudio para identificar el agente infeccioso.

Posición:

Decúbito dorsal.

Anestesia:

General.

Instrumental:

Equipo básico de oftalmología.
Equipo de Dacrio.

Ropa:

A y B.

Material de consumo:

Gasa.
Hisopos.
Jeringas de 10, 5 y de 3 cc.
Hoja de bisturí 12 y 15.
Gasa para taponamiento nasal.

Sutura:

Seda o prolene 7/0.
Vicryl 6/0.

DESCRIPCIÓN DE LATÉCNICA
DACRIOCISTORINOSTOMIA

Previo lavado mecánico quirúrgico de manos secado de las mismas, procedo a vestirme con bata estéril y calzarme guantes con técnica cerrada. Visto mesa riñón y de mayo, acomodo instrumental por tiempos quirúrgicos. Visto al personal medico y se da por iniciado el acto quirúrgico.

La enfermera quirúrgica proporciona campo al tercio y triangular, pinza de campo, el cirujano coloca el turbante, la enfermera proporciona dos campos al tercio y sabanas al pie y tres pinzas de campo, el cirujano delimita el área quirúrgica y fijación de los mismos, la instrumentista proporciona cable de electrocautero tubo de aspiración con cánula fresier y pinza de campo se fijan al campo, la instrumentista proporciona mango de bisturí Bard Parker con hoja num. 15 y gasa seca el cirujano realiza incisión de piel a 16 ml. del canto interno, con tijeras Stevens curva y pinza de disección con dientes finas el cirujano realiza disección y corte de tejido blando hasta llegar a huesos propios de la nariz, con separador de Knappe se separan bordes incididos la enfermera proporciona disector de periostido, el cirujano efectúa exposición de hueso y limpieza del mismo y limpieza de stracker y cánula de irrigación, el cirujano realiza preparación de trepanación ósea, proporcionando irrigación continua sobre la tres fina para evitar calentamiento y visualizar el área operatoria. La enfermera proporciona disector de periostio el cirujano localiza saco lagrimal y exposición del mismo con mango de bisturí Bard Parker hoja num. 12 el cirujano efectúa colgajo del saco lagrimal de aproximadamente tres mm. Y colgajo de mucosa pituitaria nasal, la instrumentista proporciona vicryl 6/0 montado en porta agujas de castro viejo. Pinza de disección sin dientes, gancho único de tyrell y tijera de noyes el cirujano realiza formación del techo con la unión del colgajo del saco lagrimal y colgajo nasal, separación de bordes y corte de cabos de sutura con prolines 7/0 o seda montada en porta agujas de castro viejo y pinza de disección sin dientes y tijera de noyes. El cirujano sutura piel corte de cabos de sutura con gasa húmeda y seca se realiza limpieza de herida quirúrgica se coloca apósito pequeño. Se da por terminado el acto quirúrgico.

Complicaciones:

Hemorragia.
Infección.
Cierre de anastomosis.
De hisencia del sitio de la incisión..